l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Caisse nationale

Fiche technique de l'indicateur
Catégorie : **Dépistage**
Trigramme : **DOS**
Version : **1.1**

I. Description

Parmi les femmes de 50 à 74 ans inclus (< 75 ans) et à risque moyen de développer un cancer du sein, l'indicateur est validé pour celles ayant bénéficié d'un dépistage du cancer du sein par mammographie de dépistage depuis 2 ans ou moins, ou par mammographie classique depuis 1 an ou moins.

Les femmes qui n'ont plus de sein, qui ont ou ont eu un cancer du sein ou un carcinome canalaire *in situ*, ou qui ont un facteur de risque connu de cancer du sein, sont exclues de l'indicateur.

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les femmes de 50 à 74 ans inclus (< 75 ans) […]* » :

- Sexe = Femme
  ET
- Age ≥ 50 ans ET < 75 ans

2. Critères d'exclusion

« *Les femmes qui n'ont plus de sein, […]* » :

- Deux antécédents de mastectomie totale (codes CCAM = « **QEFA003** », « **QEFA005** », « **QEFA010** », « **QEFA012** », « **QEFA013** », « **QEFA015** », « **QEFA019** », ou « **QEFA020** »)

« *[…] qui ont ou ont eu un cancer du sein ou un carcinome canalaire in situ, […]* » :

- ALD active ou antécédent de cancer du sein (code CIM10 = « **C50*** »)
- ALD active ou antécédent de carcinome canalaire *in situ* (code CIM10 = « **D051** »)
- Antécédent de tumorectomie ou mastectomie avec curage ganglionnaire (codes CCAM = « **QEFA001** », « **QEFA003** », « **QEFA005** », « **QEFA008** », « **QEFA010** », ou « **QEFA020** »)

« *[…] ou qui ont un facteur de risque connu de cancer du sein, […]* » :

- Exonération du ticket modérateur (hors ALD) pour antécédent familial avec mutation génétique BRCA1 ou BRCA2 documentée (code CIM10 = « **Z803** » ou « **Z804** »)
- ALD ou antécédent de carcinome lobulaire *in situ* (code CIM10 = « **D05*** ») dans les 10 dernières années
- Exonération du ticket modérateur (hors ALD) pour hyperplasie canalaire atypique, hyperplasie lobulaire atypique, ou carcinome lobulaire *in situ* (code CIM10 = « **D050** ») dans les 10 dernières années

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] un dépistage du cancer du sein par mammographie de dépistage depuis 2 ans ou moins, ou par mammographie classique depuis 1 an ou moins.* » :

- Mammographie de dépistage (code CCAM = « **QEQK004** ») dans les 24 derniers mois
- Mammographie bilatérale (code CCAM = « **QEQK001** ») dans les 12 derniers mois

- Mammographie unilatérale sur sein restant (code CCAM = « **QEQK005** ») dans les 12 derniers mois, si et seulement si antécédent de mastectomie totale unilatérale (codes CCAM = « **QEFA012** », « **QEFA013** », « **QEFA015** », ou « **QEFA019** »)
- Deux mammographies unilatérales (code CCAM = « **QEQK005** ») réalisées à la même date, dans les 12 derniers mois

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patiente « médecin traitant » de 50 à 74 ans au 31/12 de l'année N (à l'exclusion des patientes ayant un motif d'exclusion), le médecin est rémunéré si la patiente a bénéficié d'un dépistage du cancer du sein par mammographie de dépistage entre le 01/01 de l'année N-1 et le 31/12 de l'année N, ou par mammographie classique entre le 01/01 et le 31/12 de l'année N.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre l'adhésion au programme de dépistage organisé du cancer du sein parmi ses patientes éligibles à ce dépistage organisé, c'est-à-dire parmi ses patientes à risque moyen de développer un cancer du sein.

Conformément aux recommandations en vigueur, le dépistage organisé du cancer du sein repose sur la réalisation d'une mammographie de dépistage (examen clinique par le radiologue assorti d'une mammographie bilatérale avec double lecture) tous les 2 ans. Autrement dit, une personne éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a bénéficié d'une mammographie de dépistage depuis 2 ans ou moins. L'arrêté précise qu'il est recommandé de ne pas exclure systématiquement les femmes qui auraient eu un examen précédent effectué en dehors du cadre du programme de dépistage organisé entre 12 et 24 mois auparavant. Ainsi, une femme ayant bénéficié d'une mammographie bilatérale classique (ou unilatérale classique sur sein restant) peut être considérée comme « à jour » pendant 1 an.

Le ciblage de la population éligible, c'est-à-dire des personnes à risque moyen de développer un cancer du sein, s'appuie sur les recommandations de la HAS. Il s'agit de toutes les femmes de 50 à 74 ans, à l'exclusion des celles qui se trouvent dans les situations suivantes :

- Les femmes qui n'ont plus de sein, et qui ne peuvent donc plus développer de cancer du sein ;
- Les femmes qui ont ou ont eu un cancer du sein ou un carcinome canalaire *in situ*, qui relèvent d'une stratégie de suivi individuel adaptée ;
- Les femmes qui présentent un facteur de risque particulier (antécédent familial avec mutation génétique BRCA1 ou BRCA2 documentée, hyperplasie canalaire atypique, hyperplasie lobulaire atypique, ou carcinome lobulaire *in situ* diagnostiqué dans les 10 dernières années), qui relèvent d'une stratégie de dépistage individuel adaptée ;
- Les femmes qui ont signalé à l'assurance maladie un motif d'exclusion du dépistage organisé du cancer du sein (motif parmi ceux précités, ou irradiation thoracique à haute dose pour un lymphome de Hodgkin, ou prédisposition familiale particulière).

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049025564
- HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/c_1741170/fr/depistage-du-cancer-du-sein-en-france-identification-des-femmes-a-haut-risque-et-modalites-de-depistage

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Risque d'écart négligeable ;

b. Critères d'exclusion

- Cancer du sein ou carcinome canalaire *in situ* ou carcinome lobulaire *in situ* diagnostiqué mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée, et sans que ce diagnostic n'ait été codé lors d'un séjour en établissement ;
- Antécédent familial avec mutation génétique BRCA1 ou BRCA2 documentée, ou hyperplasie canalaire atypique, ou hyperplasie lobulaire atypique, ou carcinome lobulaire *in situ* diagnostiqué mais sans que la demande d'exonération du ticket modérateur correspondante n'ait été demandée/renseignée

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Mammographie bilatérale (ou unilatérale sur sein restant) réalisé dans le cadre d'un séjour en établissement, sans codage spécifique de l'acte.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : aucune profondeur (sexe et âge uniquement)
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : profondeur maximale disponible
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 24 mois
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : 1er jour du mois du 48ème anniversaire

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- ✓ PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie